

衛生福利部桃園醫院新屋分院兒童發展聯合評估中心
綜合報告書

新屋分院113.11.25修訂版

● 病歷號碼：

● 身份證字號：

● 姓名：

● 性別：男 ▾

● 生日：民國 111 ▾ 年 11 ▾ 月 28 ▾ 日

● 年齡：2 ▾ 歲 4 ▾ 月

● 早產兒矯正年齡：- ▾ 歲 - ▾ 月

醫師門診日期：

民國 114 ▾ 年 4 ▾ 月 1 ▾ 日

治療師第一項評估日期：

民國 114 ▾ 年 4 ▾ 月 1 ▾ 日

綜合報告書完成通知日期：

民國 114 ▾ 年 5 ▾ 月 6 ▾ 日

(本次為 初 ▾ 評)

下次複評日期：需要訓練 ▾

民國 115 ▾ 年 7 ▾ 月 30 ▾ 日

評估專業領域

1. 小兒神經科醫師：

2. 兒童青少年精神科醫師：

3. 復健科醫師：吳昌政

4. 小兒科醫師：

5. 精神科醫師：

6. 耳鼻喉科醫師：

7. 眼科醫師：

8. 遺傳科醫師：

9. 臨床心理師：鄭文萱

10. 物理治療師：謝寧

11. 職能治療師：賴沛吟

12. 語言治療師：簡銘萱

13. 社會工作師：簡銘彥

14. 聽力師：

15. 其他專業領域：

簽章：

醫院聯絡電話：03-4971989 分機 5640 醫院聯絡人員：李可蓉

※請家長將此份綜合報告書提供療育單位專業人員作為參考。

1. 依據兒童及少年福利與權益保障法規定，政府應建立 6 歲以下兒童發展評估機制，衛生福利部爰需蒐集受評者身分證字號(居留證)、姓名、性別、出生日期、醫師門診日期、治療師第1項評估日期、綜合報告書完成通知日期、評估專業領域、疾病診斷、評估結果、病因分類等資料。
2. 前述資料亦將提供教育部國民及學前教育署、各直轄市、縣(市)政府教育局(處)、特殊教育學生鑑定及就學輔導會及幼兒園執行法定職務或履行法定義務，於個案有「特殊教育鑑定、安置、輔導或擬訂個別化教育計畫(IEP)之需求」時查詢使用。
3. 上述資料之蒐集、處理及利用將依個人資料保護法規定辦理，如有相關疑問，可電洽02-2522-0888
4. 本報告書有效期限至預定下次評估日期。

壹、評估結果報告

類別	內容	
主訴與就診問題	主訴	自進入托嬰中心將近八個多月以來，老師觀察到其在語言及認知表現上相對落後，建議進一步評估。初期表現包括眼神接觸較少，需要較多引導，對同儕互動反應不明顯。約在1歲10個月時開始接受職能治療，至今約半年，自費語言治療也持續進行了約4個月。近期眼神接觸增加，開始出現仿說行為。情緒起伏仍較大，常需透過物品交換才能安撫情緒。現階段在托嬰中心的適應情況進步，較能夠回應老師呼喚。近期接受鑑定安置，預計進入國小附幼兩歲專班。
	就診問題	☐ 生理 ☐ 視力 ☐ 聽覺功能 ☐ 粗大動作 ☒ 精細動作 ☐ 認知 ☒ 情緒 ☐ 行為 ☐ 學習 ☐ 社會適應 ☒ 人際互動 ☐ 感覺統合 ☒ 語言溝通 ☐ 吞嚥障礙 ☐ 注意力 ☐ 活動量 ☐ 衝動性 ☐ 日常活動功能(請註明) ☐ 遺傳諮詢 ☐ 開立(更新)證明 ☐ 輔具需求 ☐ 追蹤評估 ☐ 其他：
團隊評估總結	復健科醫師：個案可以走路及跑步，上下樓梯需要扶扶手，不太會雙腳跳。會使用湯匙，會開瓶蓋，使用握拳式握筆，會畫線。語言理解只有部分，會說的詞彙大概10種，不太會認身體部位，開始有一點假裝遊戲。 團隊評估建議：個案語言及精細動作發展遲緩，疑似自閉症類群障礙，粗大動作、認知及社會情緒臨界發展遲緩。建議持續接受物理、職能及語言治療，並至兒童心智科回診追蹤，盡快至幼兒園接受團體生活，並請學校申請巡迴輔導老師治療。並定期接受聯合評估，以了解治療狀況。	
疾病診斷	疑似：F84 - 廣泛性發展障礙(泛自閉症類群障礙)/自閉症	
	確定：F88 - 其他心理發展障礙/混合性發展遲緩	
評估結果	知覺動作發展	發展遲緩 ▾
		▲ ▾ 粗大動作 ■ ▾ 精細動作 ▲ ▾ 感覺統合失調 ☐ ▾ 動作靈巧與協調度異常 ☐ ▾ 其他：
	語言發展	發展遲緩 ▾
		☐ ▾ 說話異常 ■ ▾ 語言理解 ■ ▾ 語言表達 ■ ▾ 混合性語言 ☐ ▾ 其他：
認知發展	臨界發展遲緩 ▾	
符號說明 ☐ 無異常 ■ 遲緩 ▲ 臨界		

		▲ ▾ 認知全面遲緩 □ ▾ 內部能力表現不一致 □ ▾ 其他：
	社會情緒發展	臨界發展遲緩 ▾
		▲ ▾ 情緒表現 ▲ ▾ 環境適應 ▲ ▾ 人際互動 □ ▾ 其他：
	感官功能	未進行此項評估 ▾ - ▾ - ▾
		聽力： (左____分貝;右____分貝) 視力： (左____;右____)
	其他發展	臨界發展遲緩 ▾
		□ ▾ 吞嚥功能 ▲ ▾ 日常生活功能 □ ▾ 視知覺 □ ▾ 聽知覺 □ ▾ 注意／執行功能 □ ▾ 過動／衝動 □ ▾ 其他：
綜合建議	☒ 符合證明申請資格	☒ 身心障礙證明 ☐ 重大傷病卡 ☒ 發展遲緩診斷證明書
	☒ 追蹤評估諮詢	☒ 門診追蹤 ☐ 小兒神經科／小兒科 ☒ 兒童青少年精神(兒童心智)科／精神科 ☒ 復健科 ☐ 其他： ☐ 藥物治療 ☐ 手術治療 ☐ 輔具配置 ☐ 聽力檢查 ☐ 視力檢查 ☐ 護理諮詢 ☐ 牙齒矯正 ☐ 遺傳諮詢 ☐ 營養諮詢 ☐ 其他：
	☒ 相關療育與資源	☒ 物理治療 ☒ 職能治療 ☒ 語言溝通治療 ☐ 吞嚥治療 ☐ 聽能復健 ☐ 認知訓練 ☐ 行為訓練 ☐ 聽覺輔具驗配 ☒ 社交互動技巧訓練 ☐ 心理諮商與治療 ☒ 親職教育 ☒ 家庭處遇 ☐ 福利諮詢 ☐ 視力矯治 ☐ 其他：

貳、評估結果與療育建議書

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
知覺動作功能	粗大動作 臨界發展遲緩 ▾	評估日期: 114年 4 ▾ 月 8 ▾ 日 評估結果: 目前能力約 1 ▾ 歲 7 ▾ 個月 ~ 2 ▾ 歲 4 ▾ 個月 百分位: 13 % 發展商數: 83 標準分數: 22 評估工具: ☒ 臨床觀察 肌肉張力或動作型態異常: 肌肉張力低 ☒ 臨床晤談 ☐ 阿爾伯塔嬰兒動作量表 (AIMS) ☒ 皮巴迪動作發展量表第二版 (PDMS-2) ☐ 嬰幼兒綜合發展量表 (CDIIT) ☐ 兒童動作ABC評量表第二版 (Movement Assessment Battery For Children-2, Movement ABC-2) ☐ 布魯茵克斯-歐西瑞斯基動作量表第二版 (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, BOT-2) ☐ 學前兒童粗大動作品質量表 ☐ 日常生活功能量表中文版 (PEDI-C) ☐ 其他: 行為觀察及綜合結果: - 依據臨床觀察與標準化評估結果進行綜合判斷, 目前粗大動作發展之程度落於 臨介發展遲緩 ▾ 範圍。 - 皮巴迪動作發展量表發展測驗結果: - 靜態穩定能力: 落於 正常發展範圍 ▾ 原始分數: 40 標準分數: 10 百分等級: 50 發展年齡: 28 M - 動態移動能力: 落於 臨界發展遲緩 ▾ 原始分數: 96 標準分數: 6 百分等級: 9 發展年齡: 20M - 物體操作能力: 落於 臨界發展遲緩 ▾ 原始分數: 15 標準分數: 6 百分等級: 9 發展年齡: 21M - 行為觀察結果: - 動作及姿勢表現: 上樓梯時可不扶扶手、一腳一階行走, 會將雙手平舉於身體兩側以協助維持平衡。下樓時動作相對謹慎, 會略為側身並放低重心, 以增加安全感與穩定性。投擲能力方面, 能舉手將小球往前拋出, 尚未能對準目標進行投擲, 動作以直臂揮出為主, 尚未出現低手拋球方式。接球方面, 能在語言或動作提示下伸手準備接球, 不一定能順利接到。可以雙手將皮球向前丟出, 有基本的控制與力量運用。跳躍動作方面, 目前尚未觀察到原地雙腳跳或向前跳的動作, 顯示下肢肌力及動作協調仍在發展中。 - 活動及參與度方面: 孩子與父母一同進入治療室, 準備入座時

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		出現明顯情緒，大聲哭泣，對陌生情境有些不安與抗拒。爸爸上前安撫，以繪本吸引其注意力，隨後孩子被球池吸引，開始主動將球從斜坡滾下，平時也對感官與動作的遊戲較感興趣。相較於爸爸手中已接到的球，更偏好從球池中拿球進行遊戲，對物品比對人有興趣。過程中，曾與爸爸有兩次一來一往滾球互動，隨後轉身繼續拿球池中的球。治療師上前嘗試引導進入評估活動時，孩子會轉身離開，尋找其他可玩的物品。因此採取較為彈性的方式，將評估材料放置在一旁，觀察其自主探索的情況。偶爾孩子會注意到這些物品並主動操作。 3) 行動的輔具及適應性策略為：可以獨立行走，喜歡上下樓梯、斜坡等，在公園中喜歡溜滑梯，會害怕盪鞦韆。 4) 身體功能與結構方面：無明顯結構異常。
	粗動作訓練 需要訓練 ▾	訓練方向： ☐ 誘發姿勢控制或姿勢變換的能力 ☐ 增加走路、爬行或上下樓梯等移位能力 ☒ 增加動態或是靜態平衡能力 ☐ 增加粗動作學習或粗動作計畫的能力 ☒ 增加物品傳接的能力 ☐ 增加運動相關技巧或動作協調性 ☒ 增加粗動作遊戲的能力 ☐ 增加呼吸功能或心肺耐力 ☐ 增加肌力、肌耐力或調整肌肉張力 ☐ 增加關節活動度或柔軟度 ☐ 促進與社會參與相關之動作功能 ☐ 其他(請敘明)： 具體建議： 1. 建議每週進行 1-2 次的粗大動作活動或物理治療，每次30分鐘以上，並進行居家訓練活動建議及家長諮詢。 2. 居家練習與環境建議： 1) 練習張眼墊腳尖站(雙手舉高擦窗戶、往高處貼貼紙、與大人擊掌等)。 2) 練習張眼單腳站(靠牆穿脫褲子襪子、洗澡時將腳抬高、踢球預備姿勢)。 3) 牽手協助原地跳。 4) 練習以高手及低手的方式將球向前丟。 5) 孩子對球類活動有高度興趣，可透過球的遊戲作為媒介，融入他的遊戲中，建立一來一往的互動模式，並在自然情境中引導他理解並回應簡單的指令，提升其社會互動與語言理解能力。 6) 目前孩子尚未出現跳躍的動作，建議可先從提升平衡感與下肢肌力著手，為日後跳躍能力打下基礎。日常生活中可以多安排走不平的地面(如草地、沙地)、上下樓梯、跨過小障礙物等活動，增進平衡控制能力。也可以引導孩子練習爬小斜坡、牽

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		著手踮腳走，或是雙腳踩穩後小幅度地彈動。透過這些活動，讓孩子在遊戲中練習，增加信心並為日後跳躍動作的發展做準備。 7) 建議每日提供2度連續活動30分鐘。 3. 休閒娛樂建議： 1) 可以增加跑步的機會，增加手腳協調能力及下肢肌力。 2) 可以帶個案從事爬山、健走等活動，可以增加肌力與運動耐力。走在不同材質的路面(水泥、柏油、草地、泥地、沙地等)，可以增加腳掌內肌肉的使用，有助於足弓發展與穩定。 3) 球類活動部分，丟、接、拍、踢球，如接不到球，可以先用使用氣球練習，以放慢球降落的速度，增加成功經驗。也可以先由較大的球開始練習，成功率增加後，再改用小皮球、網球等練習丟接。 4. 參與家事建議： 1) 拿放移動有重量家具 2) 墊腳尖拿放高處物品或是擦窗戶 3) 拿垃圾去丟 4) 家長可以與個案一同完成家事，除了提升生活自理能力，也增加親子互動與不同情境下的口語表達能力。
知覺動作功能	精細動作 發展遲緩 ▾	評估日期: 114年 4 ▾ 月 8 ▾ 日 評估結果: 目前能力約 1 ▾ 歲 3 ▾ 個月 ~ 1 ▾ 歲 7 ▾ 個月 百分位: 8 % 發展商數: 79 標準分數: 13 評估工具: ☒ 臨床觀察 ☒ 肌肉張力異常: 發展遲緩 ▾, 部位: 上肢低張 ☒ 臨床晤談 ☒ 皮巴迪動作發展量表第二版 (PDMS-2) ☐ 嬰幼兒綜合發展量表 (CDIIT) ☐ Bayley Scales of Infant and Toddler Development, 4th (Bayley-4) ☐ Test of Visual-Motor skill 3rd Edition ☐ 布魯茵克斯-歐西瑞斯基動作量表第二版(Bruininks- Oseretsky Test of Motor Proficiency, BOT-2) ☐ 兒童動作ABC評量表第二版 (Movement Assessment Battery For Children-2, Movement ABC-2) ☐ 其他: 行為觀察及綜合結果: 1. 依據臨床觀察與標準化評估結果進行綜合判斷，精細動作結果落於: 發展遲緩 ▾ 2. 皮巴迪動作發展量表測驗結果 1) 抓握能力: 落於 正常發展範圍 ▾ 原始分數: 41 標準分數: 8 百分等級: 25% 發展年齡: 15 M

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		2) 視動整合能力:落於 發展遲緩 ▾ 原始分數:83 標準分數:5 百分等級:5% 發展年齡:19M
	精細動作訓練 需要訓練 ▾	訓練方向: ☐ 發展慣用手 ☐ 發展抓握、拈取及釋放等基本手功能 ☒ 提升手部肌力肌力、肌耐力 ☒ 增進雙手使用能力／協調性 ☐ 提升力量調節及動作速度之控制 ☐ 提升手部操作各種工具之技巧(包括剪刀、筆、膠水等之使用) ☐ 提升手眼協調 評估時表現: 1. 感覺動作: 1) 使用拳握式的方式握筆。 2) 可以使用對掌的抓握方式抓握物品, 也能捏取小東西。 3) 不會使用剪刀。評估時, 因為孩童配合度不佳, 也未見孩童嘗試打開剪刀。 4) 可以一頁一頁翻書及打開瓶蓋。 2. 認知整合及認知要素: 可以在動作示範下, 模仿執行活動, 但因為配合度不佳, 所以表現不穩定。大部分時間都對於叫喚無反應, 但對於父母的叫喚偶爾會有反應。 3. 心理社會及自我管理: 孩童由父母陪同評估, 評估時, 情緒不穩定, 會哭鬧拒絕評估。但經安撫後可以短暫配合評估, 但整體配合度仍偏低, 經常遊走做自己喜歡的事, 眼神接觸也較短暫。 具體建議: 1. 建議進行職能治療及居家活動練習。 2. 居家練習與環境建議: 1) 提供手部需出力氣及抗阻力, 且維持 5-10 分鐘的活動, 例如: 擰乾毛巾、組合需要手指力氣的玩具、壓泡泡紙或密封袋口、吊單槓、捏黏土。 2) 提供各式玩具以增加視動整合及增加手部操作經驗, 例如: 積木砌壘、樂高、組合玩具、珠子串連、魔鬼氈玩具、旋轉螺絲、益智玩具、鈕扣操作、紙張揉捏、仿摺紙、存錢筒、鑷子取物、衣夾、黏土塑形。 3) 執行美勞、手作活動提供孩子使用各式文具的經驗, 例如: 膠水、剪刀、執筆練習模仿畫直線、畫橫線、圓形。 4) 提供需要雙手操作的玩具, 如: 搭建積木、串珠, 以提升雙側整合能力。

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
知覺動作功能	感覺統合 疑似失調 ▾	評估日期: 114年 4 ▾ 月 8 ▾ 日 評估工具: 感覺處理 ☒ 感覺處理能力剖析量表 7-36 個月 (Sensory Profile) 中文版 ☐ 感覺處理能力剖析量表 3-10 歲 (Sensory Profile) 中文版 視覺動作 ☐ 拜瑞布坦尼卡視覺-動作統整發展測驗中文版 (The Berry-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, VMI), 英文版則為第6版 ☐ 視知覺技巧測驗第 4 版 (Test of Visual Perceptual Skills 4th Edition) ☐ 視知覺發展測驗第 3 版 (Developmental Test of Visual Perception-3) ☐ 非動作視知覺測驗第 4 版 (Motor-Free Visual Perception Test-4) 整體功能 ☒ 臨床觀察 ☒ 臨床晤談 ☐ 動作問題簡易量表 (Quick Motor Problem Inventory) ☐ 嬰兒感覺功能測驗 (Test of Sensory Functions in Infants) ☐ Degangi-Berk 感覺統合測驗 (Degangi-Berk Test of Sensory Integration) ☐ 感覺統合臨床評量 (Sensory Integration Clinical Observation, SICO) ☐ 其他(請敘明): 行為觀察及綜合結果: 1. 孩童整體肌肉張力偏低, 專注力持續度較短暫。 2. 孩童情緒起伏大, 當行為被制止時, 常有強烈的情緒反應。 3. 依據感覺處理能力剖析量表結果顯示, 孩童有感覺逃避的現象, 在某些情境下容易退縮、挑食及拒絕嘗試新事物。 4. 依據臨床觀察與標準化評估結果進行綜合判斷, 目前感覺統合發展程度落於: 臨界發展遲緩 ▾ 感覺處理能力剖析量表 (Sensory Profile) 中文版 測驗結果如下 1) 聽覺處理: 正常 ▾ 2) 視覺處理: 正常 ▾ 3) 前庭覺處理: 正常 ▾ 4) 觸覺處理: 正常 ▾ 5) 口腔感覺處理: 正常 ▾ 象限總分表格 1) 低登錄量: 正常 ▾ 2) 感覺尋求: 正常 ▾ 3) 感覺敏感: 正常 ▾

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		4) 感覺逃避: 邊緣 5) 低閾值: 正常
	感覺統合訓練 需要追蹤及諮詢	訓練方向: ☒ 警醒度最佳化 ☒ 感覺系統正常化 (normalization) ☐ 建立對身體部位及功能的瞭解 (body schema) ☐ 改善視覺動作協調功能 ☐ 改善平衡及兩側協調功能 ☐ 改善動作計畫功能 具體建議: 1. 建議在日常生活中融入感覺統合的訓練及居家活動。 2. 居家練習與環境建議: 1) 提供富含感覺經驗的動作遊戲, 例如追趕跑跳、跳躍障礙物、球類活動、騎腳踏車、滑步車等活動。 2) 藉由豐富的遊戲經驗使其能夠了解各種訊息及訊息代表的意義。 3) 透過遊戲及感官活動, 維持適當警醒度並且對刺激作出適當的反應。 4) 提供多步驟的感覺統合活動, 訓練大腦整合及處理訊息, 並計畫適當的動作順序及策略。 5) 增加日常生活中動作經驗的多元性, 讓個案多玩一些體能活動, 像是球類、跳格子、走公園小花檯、律動、吊單槓、公園玩攀爬架、盪鞦韆、溜滑梯、草地或沙地上行走等活動, 讓個案能有機會學習整合各種不同之刺激並作出適當的反應, 過程應避免機械化重複的練習, 而是在自然遊戲或活動過程中學習動作計畫及平衡與協調。 6) 提供安全經驗進行感覺系統教育, 慢慢暴露各種刺激, 使個案能夠在安全舒適的狀態下習慣並接收新事物與刺激, 使各項感覺系統作出正常反應。
吞嚥 / 口腔功能	口腔動作 無異常	評估日期: 114年 4 月 1 日 ☐ 過度敏感 ☐ 動作不協調 ☐ 動作不靈活 ☐ 張力過低 ☐ 張力過高 ☐ 反應遲鈍 ☐ 流口水 ☐ 其他: 行為觀察及綜合結果: 個案臉部外觀對稱無歪斜, 且口腔動作無明顯異常, 休息及遊戲時皆無流涎。
	口腔功能訓練 不需要	訓練方向: ☐ 減／增 敏感訓練 ☐ 口腔動作訓練: (可複選) ☐ 雙唇動作訓練

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		☐ 舌頭動作訓練 ☐ 下頷動作訓練 ☐ 咀嚼動作訓練 ☐ 其他：
	吞嚥反射 無異常 ▾	行為觀察及綜合結果： 個案吞嚥反射無明顯異常。
	吞嚥功能 無異常 ▾	會噎食： ☐ 固體 ☐ 半固體 ☐ 液體 主要食材： 行為觀察及綜合結果： 媽媽表示個案能進食一般食物且無噎咳，吞嚥功能無明顯異常。
	吞嚥訓練 不需要 ▾	訓練方向： ☐ 改變姿勢 ☐ 控制量： ☐ 食物材質的選擇： ☐ 流質 ☐ 糊狀 ☐ 軟質 ☐ 固體 ☐ 食器的選擇： ☐ 奶瓶 ☐ 杯子 ☐ 湯匙 ☐ 筷子 ☐ 其他：
口語溝通功能	口語理解 發展遲緩 ▾	評估日期：114年 4 ▾ 月 1 ▾ 日 評估結果：目前能力約 - ▾ 歲 - ▾ 個月 百分位：<5 % 發展商數： T分數： 評估工具： ☒ 臨床觀察 ☒ 臨床晤談 ☐ 修訂畢保德圖畫詞彙測驗 (PPVT-R) ☐ 修訂學前兒童語言障礙評量表 ☐ 修訂學齡兒童語言障礙評量表 ☐ 學前兒童語言能力測驗 ☐ 嬰幼兒綜合發展測驗 (CDIIT) ☒ 零至三歲華語嬰幼兒溝通及語言診斷測驗 (0-3CLST) ☐ 華語兒童理解與表達詞彙測驗 (REVT) ☐ 學前幼兒與國小低年級兒童口語語法診斷測驗 ☐ 其他(請敘明)： 行為觀察及綜合結果： 個案由爸爸、媽媽陪同進入治療室，起初進入評估場所時會稍微哭

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		開、不願進入，但在給予增強物及鼓勵後，開始會主動探索環境，但對於較不熟悉的人仍會保持距離，待熟悉後可配合部分測驗活動，整體配合度尚可。評估過程中，個案經常拿取自己感興趣的玩具，操作玩具時都是自己玩較多，偶爾可模仿玩具的聲音。遊戲部分，個案可操作玩具(車子、球、聲光玩具)，但遊戲變化較少，有時可與爸爸輪替互丟球2-3次，但會被其他物品吸引而中斷遊戲，遊戲持續度不長。個案與他人偶有眼神接觸，接觸時長及頻率皆短，且共同注意力不佳。 語言理解： 個案對於叫名反應尚可，能理解自己的名字、部分家人稱謂(媽媽)及動物稱謂(鴨子、狗、蛇)及部分日常用品(水、尿布)，對於五官名稱及水果詞彙理解不穩定，未能理解物品功能(如：刀子)和抽象概念(如：大小)。指令部分，個案可理解日常一步驟指令(水水拿過來、布布拿去丟、過來坐坐)，給予手勢提示下可理解二步驟指令(如：把球撿起來，給媽媽)。句子部分，可理解A不A問句，尚未理解簡單問句(如：這是什麼?)。 整體而言，個案現階段語言理解能力與同齡兒童相比屬遲緩程度。
	理解訓練 需要訓練 ▾	訓練方向： ☐ 聽能訓練 ☐ 鼓勵兒童對話時能注視說話者 ☐ 理解手勢及肢體動作的意思(如：搖頭／搖手表示"不可以") ☐ 聽懂無手勢動作提示的單一口語指令(如：拿積木給我) ☒ 能指認一般日常生活等熟悉物品或圖片(如：杯子，蘋果) ☐ 理解形容詞、感覺、表情等抽象詞彙 ☒ 理解兩個或以上連續動作指令 ☐ 理解複雜型 ☐ 理解經歷過的事件內容 ☐ 理解故事內容 ☐ 其他： 具體建議： 1. 家長可利用繪本內容進行「聽指令找物品」的遊戲，加強孩子對二步驟與順序步驟的理解(如：先拿衣服再拿褲子；把垃圾撿起來丟垃圾桶。) 2. 家長可在每天的例行活動(如：吃飯、盥洗、喝水...等)中引導孩子理解日常生活物品與功能(如：請孩子拿"牙刷"、請孩子拿"可以擦臉的東西(毛巾)"。) 3. 家長可利用繪本內容進行「聽指令找物品」的遊戲，藉由家長提問WH-問題「誰?、這是什麼?」，加強孩子對簡單問句的理解(如：誰在唱歌? 電視在哪裡?...等)。
口語溝通	口語表達 發展遲緩 ▾	評估日期：114年 4 ▾ 月 1 ▾ 日 評估結果：目前能力約 - ▾ 歲 - ▾ 個月 百分位：<5 % 發展商數： T分數：

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
通功能		評估工具： ☒ 臨床觀察 ☒ 臨床晤談 ☐ 修訂學前兒童語言障礙評量表 ☐ 修訂學齡兒童語言障礙評量表 ☐ 嬰幼兒綜合發展測驗 (CDIIT) ☒ 零至三歲華語嬰幼兒溝通及語言診斷測驗 (0-3CLST) ☐ 華語兒童理解與表達詞彙測驗 (REVT) ☐ 其他(請敘明)： 行為觀察及綜合結果： 溝通方式與效度： 個案的溝通方式以肢體動作、聲音及部分口語為主，可以表達需求、拒絕、簡單社交互動和傳遞訊息等溝通功能，未做出詢問和表達情緒，對他人有主動溝通意圖，溝通效度可部分被理解。 語言表達： 個案現階段的表達以手勢動作、聲音及部分口語為主，看到認識的動物會發出該動物之叫聲，媽媽表示個案於家中能說出人稱詞彙、ㄋㄟㄋㄟ、棒棒，表達詞彙量少且大多以"恩"加上動作表達需求。評估過程中，個案自發口語大多為母音(如：啊、恩)，偶爾可模仿聲音(如：鴨子的叫聲"ㄍㄚ"、狗狗叫聲"汪汪")。手勢動作部分，個案目前可做出指物、揮手打招呼 and 搖頭表達拒絕。 整體而言，個案語言表達能力與同齡兒童相比屬發展遲緩。
	表達訓練 需要訓練 ▾	訓練方向： ☐ 使用溝通輔具人手勢／手語輔助溝通 ☐ 提升語用溝通技巧 ☒ 增加主動表達的意願和機會 ☒ 模仿發聲或模仿語音(發聲遊戲) ☒ 以單字加上手勢動作表達，如：我要 ☒ 加強詞彙使用，如：常見物品名稱、功能性詞彙 ☐ 加強完整句的表達，如：我要喝水 ☐ 加強抽象詞彙的表達，如：好大的車子 ☐ 增長語句長度 ☐ 練習使用複雜句表達(如：因為...就...) ☐ 練習描述經歷過的事件或說故事 ☐ 其他： 具體建議： - 家長可在與孩子遊戲過程中，使用孩子喜歡的玩具介入並給予豐富的語言刺激，觀察孩子是否會跟著模仿聲音。 - 建議家長可透過模仿環境音(如：交通工具)和動物聲，增加孩子不同的語音變化，當孩子有模仿時，大人可再次模仿孩子的反應，並給予口頭鼓勵。

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		3. 家長可向孩子介紹每天的例行活動(如:吃飯、盥洗、購物...等)中會接觸的人物及物品, 在與孩子遊戲互動時, 可加入今天所看到的人、事、物名稱, 幫助孩子理解並命名常見的人事物。
口語溝通功能	語用訓練 需要追蹤及諮詢 ▾	訓練方向: ☐ 建立對事物的廣泛興趣, 勿過於侷限 ☐ 維持合乎情境的對話主題 ☐ 維持一來一往的對話輪替 ☐ 能使用合乎情境的適當口語 ☐ 能聽懂笑話、雙關語或詞彙非字面的意義 ☐ 能適切的開啟及結束對話 ☐ 增加語用預設的能力 ☐ 其他:
	說話 需要追蹤及諮詢 ▾	評估日期: 114年 4 ▾ 月 1 ▾ 日 評估結果: ☐ 構音障礙 ☐ 言語不流暢／口吃／迅吃 ☐ 嗓音障礙 ☐ 其他: 個案在說話和發聲時, 其共鳴和嗓音品質無異常, 音個案口語能力正在發展中, 因此構音/音韻表現與說話流暢度仍需再觀察。 ☐ 評估工具: ☐ 國語正音檢核表 ☐ 華語兒童構音與音韻測驗 ☐ 修訂中文口吃嚴重度評估工具(兒童版) ☒ 其他(請敘明): 臨床觀察 訓練方向 ☐ 構音矯正 ☐ 語暢訓練 ☐ 嗓音復健 ☐ 嗓音保健 ☐ 其他: 具體建議: 持續觀察個案表現, 並建議持續於醫療院所接受語言治療介入。
認知功能	認知功能 臨界發展遲緩 ▾	評估日期: 114年 4 ▾ 月 8 ▾ 日 評估結果: 1. 發展商數或智商(百分位): 個案整體認知表現落於臨界範圍(BSID-3: Cog:CCS=80,9%ile,95% C.I.=74-90)。 2. 分量表(發展年齡/SS): 相等於21個月之孩童能力。

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		評估工具： ☒ 臨床觀察 ☒ 臨床晤談 ☒ 貝萊嬰幼兒發展量表 (Bayley-III 或 IV) ☐ 魏氏幼兒智力量表 (WPPSI-R 或 IV) ☐ 魏氏兒童智力量表 (WISC-IV 或 V) ☐ 斯比智力量表 (S-B V) ☐ 萊特國際操作量表 (Leiter-R 或 III) ☐ 穆林早期學習量表 ☐ 托尼非語文智力測驗—再版 (幼兒版 E1-7) ☐ 適應行為評量系統第二版 (ABAS-II) ☐ 社會適應表現檢核表 ☐ 文蘭適應行為量表教室版或第三版 (VABS 或 VABS-III) ☐ 電腦化持續性注意力測驗 Conner's Continuous Performance Test (CPT II) 或 (CPT III) 或 Conner's Kiddie Continuous Performance Test II (KCPT II) ☐ 其他(請敘明)： 行為觀察： 個案由案父母陪同前來，外觀整潔。在案父母陪同下，適應新環境能力可。個案一開始眼神接觸少，多將注意力放在玩具上，喚名偶有反應。在衡鑑的中期，個案可有6-7次自然的眼神對視。評估現場未見個案出現手指指示，有需求時可邊發出聲音，邊伸手表示自己想要的物品。個案可模仿主試者的假扮性遊戲內容，但無法模仿使用原子筆取物，多在觀察筆的外觀。個案情緒平穩，遇挫折時會主動尋索母擁抱。情境轉換能力可，不需事先預告即可收拾玩具，會揮手表示「bye-bye」，離開衡鑑室。 個案口語表達以無意義發聲為主，可仿說單詞，可理解如：拿拿等簡易指令。整體衡鑑過程中，個案注意力維持度可，大多時候可安坐於位，測驗開始15分鐘後才開始遊走，想要尋找新玩具。以其有興趣之物品吸引下可回位，繼續受測。 綜合結果： 使用貝萊嬰幼兒發展量表第三版(Bayley-III)認知量表了解個案認知表現。個案整體認知表現落於臨界範圍(BSID-3: Cog:CCS=80,9%ile,95%C.I.=74-90)，相等於21個月之孩童能力。評估現場可見個案可在時限內完成插棒、紅藍鑲嵌版，找到透明和兩側之物。個案未展現自發性的假扮遊戲，僅能模仿主試者示範之遊戲內容。其無法模仿主試者使用筆取物，僅探索筆的外觀，也尚無法模仿兩步驟動作。
	認知功能訓練 需要追蹤及諮詢 ▾	訓練方向： ☐ 嬰兒刺激／促發活動

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		☒ 認知技能促發(遊戲、物品使用、符號及表徵技能、模仿能力、問題解決、區辨、概念形成、一一對應、順序能力、畫圖等) ☒ 語彙／語意、基底常識、敘事、論述與對話能力 ☐ 良好工作習慣 ☐ 專注、記憶與執行能力 ☐ 提供童書、玩具和遊戲處方 ☐ 結構環境策略 ☐ 生活適應(相關認知應用)訓練 ☐ 接受應用行為原理強化目標行為的訓練方案 ☐ 教育／社區資源參與 ☐ 其他： 具體建議： 可待孩子有更多的口語表達(如:要XX)，才給其所欲之事物，增進其口語表達能力。
社會情緒功能	情緒行為與社會適應功能 臨界發展遲緩	評估日期: 114年 4 月 8 日 評估工具： ☒ 臨床晤談 ☒ 臨床觀察 ☐ Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS 或 II) ☐ The Childhood Autism Rating Scale (CARS 或 II) ☒ Clancy Behavior Scale ☐ Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) and Modified Checklist for Autism in Toddlers , Revised with Follow-up (M-CHAT-R/F) ☐ Screening Tool for Autism in Toddlers & Young Children ☒ Bayley-III Social-Emotional Questionnaire ☐ Leiter-R 或 3 Rating Scale ☐ 適應行為評量系統第二版 (ABAS-II) ☐ 社會適應表現檢核表 ☐ 文蘭適應行為量表教室版或第三版 (VABS 或 VABS-III) ☐ 嬰幼兒綜合發展測驗 (CDIIT) ☐ 兒童氣質量表 ☐ SNAP-IV ☐ 決裂(干擾)行為量表 ☐ 兒童活動量表 ☐ 阿肯巴克實證衡鑑系統 (ASEBA; 臺灣版)、CBCL、C-TRF、TRF ☐ 其他(請敘明)： 行為觀察及綜合結果： 1. 行為特徵/情緒表現： 評估現場可見個案情境轉換能力可，未有明顯刻板重複行為，會探索

類別	評估／訓練項目	評估工具、結果與訓練方向
		各種不同類型的玩具。案父母報告個案喜歡轉圈，制止下情緒可維持平穩。其喜歡推車子、形狀鑲嵌等玩具，可依照玩具的特性玩樂，未有明顯重複固著行為。個案除堅持回家一定要先洗腳才洗手外，未有其他堅持的習慣。其在校因口味的問題，僅吃白飯，在家若將味道調的較為甜口，多願意進食不同的食物。個案可知危險，會注意身旁的環境，例如：看到階梯的高低差，會小心翼翼的避開。 情緒方面，當不順個案之意時(如：不幫他脫鞋)，個案會尖叫大哭，案父母多會順著個案，或讓他看電視、給零食等方式轉移其注意力，約10分鐘以內可平息下來。案父母覺個案在托嬰中心因吃飯、脫鞋等生活自理能力多被要求自行完成，情緒上較為壓抑，經常會有夜驚的情形，睡眠品質較為不佳。 2. 人際互動／社會情緒： 案母填答 Clancy行為表現量表結果則高於臨床切節點(16分>切節點：14分)。貝莉嬰幼兒發展量表第三版(Bayley-III)社會情緒量表結果也顯示，個案社會情緒表現落在臨界範圍(BSID-3 SE:SECS=65, 1%ile, 95%C.I.=60-77)。案父母報告個案喚名有反應，有需求時可先呼喚「媽媽」，並牽著案母的手到想要的物品之處。其僅能近距離手指指示，尚無法遠端指物。個案可仿說，可模仿動作。平日會用搖頭表示自己的意願，在口語提示下可揮手再見。個案會主動拿故事書找案父母陪讀，展露社會性笑容。個案家中較少扮家家酒的相關玩具，其較少玩樂假扮遊戲。 3. 小結 個案轉換情境能力可，生活中未觀察到具明顯刻板行為，可玩樂不同類型的玩具。人際互動方面，有非口語手勢，有需求時也可用簡易的口語表達表示。個案對人有興趣，也有社會性笑容，但整體人際互動表現仍較現薄弱，也尚無法自發玩樂的假扮遊戲。建議持續追蹤其社會情緒表現。
社會情緒功能	情緒行為與社會適應功能訓練 需要追蹤及諮詢 ▾	訓練方向： ☐ 心理行為治療(團體／個別) ☒ 提升表達身心需求能力 ☒ 提升社會互動的興趣 ☐ 增強表情辨識、情緒解讀之能力 ☐ 提升注意與理解互動對象意圖、情緒感受之能力 ☐ 提升理解情境潛規則及合宜社交應對行為(如對話、合作遊戲、友誼處理、自我調節、同理、衝突處理等) ☐ 提升情緒調節能力 ☐ 運用行為功能分析及行為改變策略處理行為問題及行為塑造 ☐ 提升團體生活之常規遵循能力 ☐ 使用教室管理策略 ☐ 親職諮商 ☐ 其他：

參、病因診斷分類表(本頁由醫療機構自行留存)

類別	分項內容		
病因分類	確定:V 可能:X	☐ ▾ 神經系統缺氧／缺血 ☐ ▾ 神經系統感染 ☐ ▾ 腦中風(缺血／出血) ☐ ▾ 神經系統外傷 ☐ ▾ 染色體／基因 ☐ ▾ 先天症候群: ☐ ▾ 代謝／內分泌障礙 ☐ ▾ 退化性疾病 ☐ ▾ 腫瘤	☐ ▾ 藥物／毒物 ☐ ▾ 兒童虐待及忽略 ☐ ▾ 次發於慢性疾病 ☐ ▾ 早產／低出生體重兒 ☐ ▾ 家庭／社區／心理社會環境 ☐ ▾ 視力障礙 ☐ ▾ 聽力障礙 ☐ ▾ 其他: ☒ ▾ 不知原因: 隱因性 ▾
相關疾病	神經相關疾病 無 ▾	☐ ▾ 腦性麻痺 ☐ ▾ 神經退化性疾病 ☐ ▾ 癲癇 ☐ ▾ 周邊神經疾病 ☐ ▾ 神經發展性障礙 ☐ ▾ 神經肌肉疾患 ☐ ▾ 其他:	☐ ▾ 水腦 ☐ ▾ 腦膜炎／腦炎 ☐ ▾ 神經皮膚症候群 ☐ ▾ 脊髓畸形 ☐ ▾ 腦發育畸形 ☐ ▾ 腦瘤
	附註:		
	感官異常 (耳部問題) 無 ▾	☐ ▾ 聽力障礙 ☐ ▾ 傳導性: ○ ▾ 左耳(分貝) ○ ▾ 右耳(分貝) ☐ ▾ 神經性: ○ ▾ 左耳(分貝) ○ ▾ 右耳(分貝) ☐ ▾ 混合性: ○ ▾ 左耳(分貝) ○ ▾ 右耳(分貝) ☐ ▾ 中樞聽覺障礙APD ☐ ▾ 其他:	
	感官異常 (眼睛問題) 無 ▾	☐ ▾ 視力不良 ☐ ▾ 屈光異常(中度或重度異常) ☐ ▾ 遠視 右眼: 左眼: ☐ ▾ 近視 右眼: 左眼: ☐ ▾ 散光 右眼: 左眼: 雙眼視功能不良 ☐ ▾ 斜視: ○ ▾ 內斜 ○ ▾ 外斜 ○ ▾ 上下斜視 ☐ ▾ 其他視功能異常 ○ ▾ 調節力異常 ○ ▾ 內聚外展失衡 ○ ▾ 影像抑制 ○ ▾ 立體感不良 診斷: ☐ ▾ 弱視(○ ▾ 右眼 ○ ▾ 左眼 ○ ▾ 雙眼)	

類別	分項內容	
		(弱視原因:) ☐ ▾ 眼疾 ☐ ▾ 遮蔽或介質模糊 (☐ ▾ 眼瞼下垂 ☐ ▾ 角膜混濁 ☐ ▾ 白內障 ☐ ▾ 其他:) ☐ ▾ 視網膜病變 ☐ ▾ 視神經萎縮 ☐ ▾ 其他: ☐ ▾ 中樞性視力障礙 ☐ ▾ 其他:
	遺傳、先天症候群 無 ▾	☐ ▾ 唐氏症 ☐ ▾ Prader-Willi 氏症候群 ☐ ▾ Goldenhar 氏症候群 ☐ ▾ 胎兒酒精症候群 ☐ ▾ Turner 氏症候群 ☐ ▾ Williams 氏症候群 ☐ ▾ 軟骨發育不全症 ☐ ▾ X染色體脆折症 ☐ ▾ Angelman 氏症候群 (快樂布偶症候群) ☐ ▾ 胎兒藥物症候群 ☐ ▾ CATCH 22 症候群 ☐ ▾ Rett 氏症候群 ☐ ▾ 先天性代謝障礙 ☐ ▾ Crouzon 症候群 ☐ ▾ 其他:
	心智發展方面 無 ▾ 確定:V 疑似:X	☒ ▾ 混合性特定性發展障礙 ☐ ▾ 發展性協調障礙 ☐ ▾ 其他特定之發展遲緩 ☐ ▾ 非特定之發展遲緩 ☐ ▾ 注意力缺損過動症候群: ☐ ▾ 注意力不足疾患, 未提及過動行為 ☐ ▾ 注意力不足疾患, 伴有過動行為 ☐ ▾ 注意力缺失過動疾患, 其他型 ☒ ▾ 廣泛性發展障礙: ☒ ▾ 自閉症 ☐ ▾ 兒童期崩解疾患 ☐ ▾ 亞斯伯格症候群 ☐ ▾ 其他廣泛性發展疾患 ☐ ▾ 廣泛性發展疾患, 未特定 ☒ ▾ 智能障礙 (等級: ☐ ▾ 輕度 ☐ ▾ 中度 ☐ ▾ 重度 ☐ ▾ 極重度 ☐ ▾ 其他) ☒ ▾ 語言障礙 (☒ ▾ 表達 ☒ ▾ 理解 ☒ ▾ 混合 ☐ ▾ 語暢 ☐ ▾ 其他) ☐ ▾ 聽障導致之語言或語文發展障礙 ☐ ▾ 特發於兒童及青少年期行為及情緒障礙 ☐ ▾ 特發於兒童及青少年期之過度焦慮症 ☐ ▾ 其他兒童期情緒疾患(包括悲傷及不快樂害羞內向)

類別	分項內容	
		☐ ▾ 特發於兒童及青少年期之人際關係困難 ☐ ▾ 兒童期其他社會功能疾患 ☐ ▾ 對立反抗症 ☐ ▾ 選擇性之不語症 ☐ ▾ 睡眠障礙 ☐ ▾ 飲食障礙 ☐ ▾ 抽動症 (Tic) ☐ ▾ 遺尿症, 遺屎症 ☐ ▾ 兒童虐待／疏忽 ☐ ▾ 其他：
	其他身體疾病 無 ▾	☐ ▾ 消化系統 ☐ ▾ 骨骼系統 ☐ ▾ 心臟血管系統 ☐ ▾ 內分泌代謝異常 ☐ ▾ 泌尿系統 ☐ ▾ 生長遲滯 ☐ ▾ 唇顎裂 ☐ ▾ 牙齒排列不整 ☐ ▾ 口功能異常 ☐ ▾ 其他：